

MANEJO Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE LA TSVP

Javier Borrego Rodríguez, Paula Menéndez Suárez, Julio César Echarte Morales, Pedro L. Cepas Guillén.

INTRODUCCIÓN

Las taquicardias supraventriculares paroxísticas (TSVP) son aquellas que se originan en las aurículas, en el nodo aurículo-ventricular, o en el haz de His antes de su bifurcación, y que desde ahí, son conducidas hacia los ventrículos a través del tejido específico de conducción cardíaco. En base a esto, podemos decir que las TPSV se caracterizan por presentar:

- **Ritmo Rápido:** con frecuencias en torno a 150 – 160 lpm.
 - **Ritmo Regular:** el intervalo entre los QRS es siempre el mismo / constante.
 - **QRS estrecho:** el QRS de estas taquicardias suele ser estrecho (QRS <120 ms); excepto si el paciente tiene un QRS ancho en su ritmo de base (p.ej. BRDHH).
 - **Inicio y final brusco:** de manera que el paciente habitualmente sabe precisar con exactitud el momento en el que comenzó con las palpitaciones, la clínica más frecuente de estas entidades.
- Ante un ECG que muestre una taquiarritmia regular de QRS estrecho, se trata de una TSVP hasta que se demuestre lo contrario



Figura 1.- Taquicardia Regular de QRS estrecho

DIAGNÓSTICO

Existen una serie de signos electrocardiográficos que nos pueden ayudar a dar una “aproximación diagnóstica” acerca de cuál es la etiología de la TSVP, puesto que el “diagnóstico definitivo” sólo se puede obtener mediante un estudio electrofisiológico (EEF). Entre las causas de una taquicardia regular de QRS estrecho, las más frecuentes en la práctica clínica son:

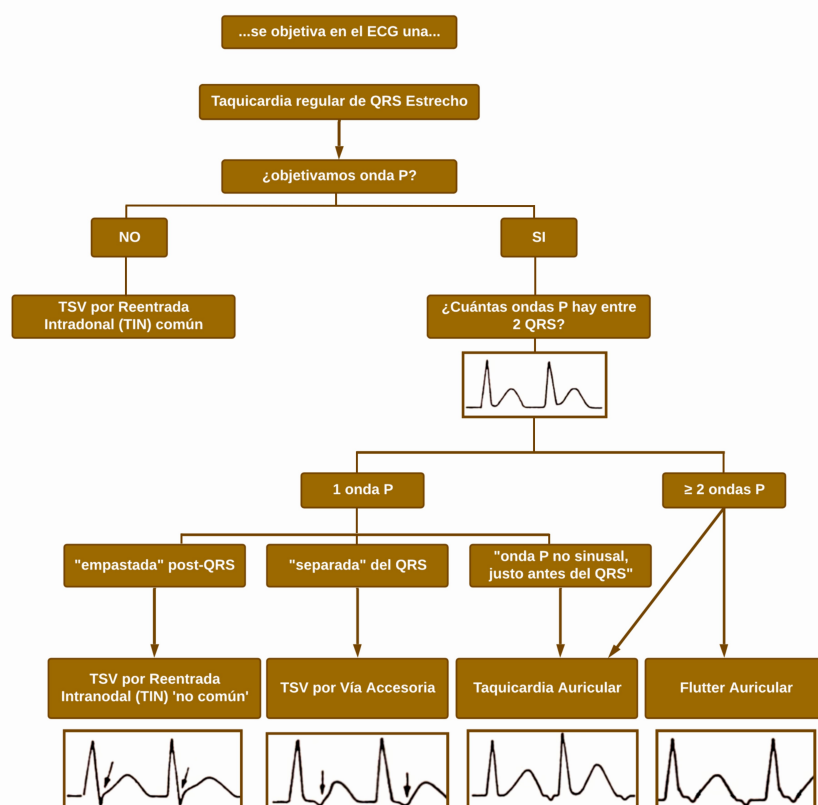
	FRECUENCIA	PACIENTE TIPO	Ondas P
• TSV por reentrada Intranodal (TIN)	70%	• 40 – 50 años	• NO*, a veces, PseudoR en V1 o pseudoS en II Distancia RP < 70 ms
• TSV mediada por vía accesorio	25%	• 10 – 30 años	• SI (1 onda P, entre 2 QRS) Distancia RP > 70 ms
• Taquicardia Auricular	< 5%	• > 70 años, cardiopatía, EPOC.	• SI (1 onda P –de morfología no sinusal-, entre 2 QRS) • (2 o más ondas P, entre 2 QRS)

	FRECUENCIA	PACIENTE TIPO	Ondas P
Flúter Auricular	< 5%	> 70 años, cardiopatía, EPOC.	NO (ondas F 'en dientes de sierra' entre 2 QRS)

En determinadas ocasiones podemos encontrar en lo que aparentemente parece una TIN, una onda P inmediatamente después y muy pegada al QRS; hablamos entonces de una "TIN no común". La principal diferencia entre esta 'TIN no común' con la TSV por Vía Accesoria es que en el primer caso la Onda P está muy pegada al QRS, mientras que en la TSV por Vía Accesoria la onda P está más separada del mismo.

Asimismo será fundamental realizar el diagnóstico diferencial con la taquicardia sinusal, que es una respuesta fisiológica ante un estrés del organismo (fiebre, anemia, infección, dolor, tromboembolismo, entre otros) y que el tratamiento es el de la causa desencadenante.

Algoritmo diagnóstico de Taquicardias supraventriculares



TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El objetivo del tratamiento es interrumpir la taquicardia y reestablecer el ritmo sinusal. El manejo inicial del paciente se realizará en función de si está o no estable hemodinámicamente. A todos los pacientes los monitorizaremos con telemetría.

1. Paciente con inestabilidad hemodinámica

- Realizaremos cardioversión eléctrica (CVE) "bifásica" a 100 J. en box de críticos, tras sedoanalgesiar al paciente y asegurar la vía aérea.

2. Paciente con estabilidad hemodinámica

En las maniobras descritas a continuación, se deberá realizar monitorización ECG, durante la

misma.

- **Maniobras Vágales:**

- **Masaje del seno carotídeo** (tras auscultar las carótidas y descartar soplo a ese nivel). Con Atropina cargada, paciente monitorizado y con carro de parada cerca al paciente)
- **Maniobra de Valsalva modificada** (paciente en la camilla incorporado a 45º, se le hace soplar por el cono de una jeringa de 10 cc durante 15 segundos. En ese momento, de forma coordinada, se tumba la camilla a 0º y se levantan las piernas a 45º, durante 15 segundos. Al cabo de este tiempo se vuelve al paciente a la posición inicial de 45º. Si esto no es efectivo administramos...

- **Adenosina (Adenocor ®):** administración. Se administran 6 mg en bolo, luego administrar suero fisiológico 0,9% 10-20 ml en bolo y elevar el brazo del paciente, con el objetivo de que el fármaco alcance el corazón lo más rápido posible, debido a que la adenosina presenta una vida media de aproximadamente 10 segundos. La adenosina está contraindicada en pacientes con hiperreactividad bronquial (Asma, EPOC avanzado y enfermos coronarios). Si con 6 mg. no se consigue el paso a ritmo sinusal, esperaremos 3 minutos, y se repetiría un bolo de 12 mg y, tras esperar otros 3 minutos, otro bolo de 12 mg o 18 mg si no fuera efectivo. Si aun así no se logra cortar la taquicardia, se administraría verapamilo.

- **Recuerda.** Si durante la administración de adenosina observas una pausa de varios segundos o aparición de extrasístoles ventriculares, no debes preocuparte, pues ambos son bastante frecuentes.

- **Verapamilo (Manidon® 1 amp de 2ml con 2,5mg/ml):** 5 mg IV en 100 ml suero fisiológico 0,9% en 2 minutos. Si no revierte, se espera 30 minutos y se administra verapamilo 10 mg en 100 ml de suero fisiológico en 10 minutos. De elección en pacientes asmáticos. Es muy importante que el verapamilo está contraindicado en pacientes con disfunción sistólica o en tratamiento concomitante con betabloqueantes. Es muy importante registrar un ECG durante este procedimiento, para objetivar cómo se comporta la taquicardia durante el bloqueo transitorio del nodo AV ya que da pistas sobre su etiología. Si la taquicardia se corta y se restaura el ritmo sinusal, indica que el nodo AV participa en el circuito de reentrada de la taquicardia (TIN, vía accesoria). En cambio, si se frena de manera transitoria pero vuelve a aparecer, a veces permite objetivar actividad auricular sugestiva de flutter auricular o taquicardia auricular; o la ausencia de la misma, más sugestiva de fibrilación auricular (que, a veces, si va muy rápido puede simular ritmicidad).
- **¿Cuándo remitir a Consulta de Cardiología?** En aquellos casos en los que las crisis sean muy recurrentes, se deberá remitir a la paciente para estudio electrofisiológico y ablación de la misma.
- **¿Cómo prevenir nuevas crisis?** El Verapamilo es un fármaco que ha demostrado en prevención secundaria una tasa de éxito del 73% en cuanto a la eliminación y/o reducción significativa del número de crisis, por lo que constituye una buena opción de cara al alta. Otra opción es el uso de betabloqueantes.

- **Recuerda:** La adenosina está contraindicada en pacientes asmáticos o EPOC severos, y el verapamilo en pacientes con disfunción sistólica o en tratamiento con betabloqueantes.

FÁRMACO	TRATAMIENTO TPSV.	TRATAMIENTO TPSV EN ASMÁTICO. EPOC.
Adenosina	6 mg IV en bolo seguido de 20 ml de suero fisiológico y brazo en alto.	No usar adenosina en paciente: ASMÁTICO, EPOC, ENFERMOS CORONARIOS
Adenosina	12 mg IV en bolo seguido de 20 ml de suero fisiológico y brazo en alto.	No usar adenosina en paciente: ASMÁTICO, EPOC, ENFERMOS CORONARIOS
Adenosina	12 mg IV en bolo seguido de 20 ml de suero fisiológico y brazo en alto si no revierte usamos verapamilo	No usar adenosina en paciente: ASMÁTICO, EPOC, ENFERMOS CORONARIOS
Verapamilo	5 mg IV en 100 ml de suero fisiológico a pasar en 2 minutos, si no sede esperar 30 minutos y luego	5 mg IV en 100 ml de suero fisiológico a pasar en 2 minutos, si no revierte esperar 30 minutos y luego.
Verapamilo	10 mg IV en 100ml de suero fisiológico a pasar en 10 minutos	10 mg IV en 100 ml de suero fisiológico a pasar en 10 minutos.

BIBLIOGRAFÍA

- Vázquez Lima, MJ, Casal Codesido JR. Guía de Actuación en Urgencias. 5º ed. Coruña: Ofelmaga SL; 2017.
- Rodríguez Padial L. Electrocardiografía Clínica. España: Aula Médica; 2018.
- Pérez Villacastín J. Electrocardiografía para el Clínico. 4º ed. Gran Canaria: Artext Ediciones SI; 2018.